

12 - 01-Révision Secourisme (Teams) - Pr. Abou Elhassan

Vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. D'accord. Donc, est-ce que vous avez pu voir le cours? Nous avons fait un rayon sur le cours de secourisme, gestes et soins d'urgence pour la deuxième année.

Alors, est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous voulez qu'on discute durant cette matinée-là? Je vois donc pratiquement 54 personnes. Alors, mademoiselle Ariane, Sonia, est-ce que vous avez des questions concernant le cours? Non, monsieur. D'accord.

Alors, vous êtes prête pour l'examen, incha'Allah? Et Hilal Amia, c'est bon? Oui, mademoiselle Saral Ghatri. Est-ce que vous avez des questions sur le cours, des choses que vous n'avez pas compris? Oui, monsieur, pour le dernier cours de l'ARECA-ATIA, pour le mécanisme de défibrillateur automatisé, etc. D'accord.

Alors, le défibrillateur somatomatique, c'est un défibrillateur qui est intelligent, qui sert à délivrer des ondes de choc lors d'un arrêt cardiaque, généralement en préhospitalier. D'accord. Donc, il y a d'autres défibrillateurs qu'on utilise dans notre hospitalier qui sont des défibrillateurs qui ne sont pas des somatomatiques, mais des défibrillateurs qui sont manuels, qui sont utilisés par les médecins.

Alors, le défibrillateur somatomatique, il permet d'analyser le rythme cardiaque et après l'analyse du rythme, il va nous indiquer est-ce qu'on peut choquer ou non. Sur les arrêts cardiaques, il y a deux types d'arrêts cardiaques. Il y a des arrêts cardiaques dites choquables, notamment les tachycardie ventriculaire et l'défibrillateur ventriculaire, et c'est ces arrêts cardiaques qu'on choque.

Il y a un autre type d'arrêt cardiaque dite les arrêts cardiaques médicaux, c'est les asystolies avec la dissociation électromécanique. Et dans ce cas là, il n'y a pas d'indication à choquer. Et ces arrêts cardiaques sont gérés généralement par le massage cardiaque externe et par l'adrénaline, ce qu'on appelle les arrêts cardiaques médicaux.

D'accord, alors le défibrillateur somatomatique, il permet d'analyser ce rythme et d'indiquer ou non le choc. On fait cette analyse à l'intérieur de l'hôpital par d'autres types de défibrillateurs, des défibrillateurs manuels. Alors, quel est le mécanisme avec lequel la défibrillation se fait? Donc, il faut savoir que les arrêts cardiaques, pratiquement tous, passent par une phase de fibrillation.

Par conséquent, il faut qu'on inverse le rythme. Il faut qu'on défibrille pour essayer de récupérer et pour renverser un rythme qui est anarchique, notamment une fibrillation, vers un rythme qui est correct, qui est sinusale. Et c'est pour cette raison là qu'on utilise la défibrillation.

Est-ce que vous avez compris mademoiselle Gatri? Oui monsieur, merci. D'accord. D'autres questions? Alors, sur l'examen, généralement c'est des questions à choix uniques.

Et ce que je vous recommande, c'est essentiellement d'analyser, d'essayer de penser d'une façon très calme sur l'intitulé de la question par la suite. Donc, vous allez pouvoir répondre généralement sans aucun souci. L'essentiel, c'est que vous compreniez les axes et les mécanismes avec lesquels on va intervenir.

Donc, devant tout cas, c'est-à-dire d'urgence inopinée, d'ailleurs c'est la définition de secourisme, c'est une urgence inopinée, il faut juste qu'on analyse la situation. Donc, il faut qu'on reste calme, il faut qu'on protège, il faut qu'on alerte et puis on fait qu'on sécurise. Donc, c'est le rythme avec lequel on travaille.

Et puis, on va analyser la situation clinique du patient, la situation où la victime est là. Est-ce que la victime a des problèmes de conscience? Donc, on évalue la conscience un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, on va évaluer la respiration.

Et puis, dans un troisième temps, on va agir en fonction de notre analyse. Donc, c'est le tripiéd, c'est la conscience, la respiration après le cœur. Alors, si votre patient est inconscient, dans ce cas-là, on va libérer les voyants supérieurs, et bien sûr, alerter, et puis évaluer la respiration.

Si le patient ou la victime ne respire pas, dans ce cas-là, nous sommes devant un patient qui est inconscient et qui ne respire pas, et c'est la définition de l'arrêt cardiaque. C'est pas conséquent, c'est pas conséquent, c'est-à-dire la victime est inconsciente, mais qui respire, dans ce cas-là, c'est un patient qui est inconscient, qui respire. Dans ce cas-là, c'est la position latérale de sécurité.

Alors, il y a une question que mademoiselle Etamie a posée. Est-ce qu'on fait alerte après ou avant la protection et le dégagement? Alors là, donc, il faut, sur le process, donc, rappelez-vous, c'est P1, donc il faut protéger, d'accord, d'accord, et puis après, donc, alerter, puis après, donc, donner des secours. Donc, c'est PAS, protection, alerte et secourisme.

Alors, dans le cas où il faut dégager, c'est la même chose. Le dégagement, donc, lorsqu'on décide de dégager une victime, c'est que nous sommes dans une ambiance où il y a un risque de sur-accident, et pas conséquent. Il faut que le secouriste se protège, il faut que protégé témoin, il faut qu'il alerte, puis après, donc, donner de secours, en fonction de l'analyse de la situation.

D'autres questions, les amis? Monsieur? Oui? Monsieur, quand la victime ne respire plus, pourquoi on présume qu'elle est en arrêt cardiaque? D'accord. Alors, lorsque la victime, donc, est inconsciente et ne respire pas, d'accord, alors, avant, avant les recommandations, donc, on disait qu'il faut aller checker le pouls, il faut aller palper le pouls pour voir est-ce que ça circule ou non? Est-ce que le patient, donc, le cœur est toujours ou non? Alors, c'est ce management avec cette méthodologie là, donc, a permis quand même de faire perdre des chances pour commencer le massage cardiaque chez les patients, surtout chez les non-professionnels de santé, parce que, donc, aller palper le pouls carotidien ou fémoral pour dire est-ce que ça circule ou non? Donc, ça

a permis quand même de perdre des chances pour le patient. Et du coup, selon la recommandation dernière, notamment celle de 2015, donc, généralement, un patient qui est inconscient et qui ne respire pas, il est considéré comme étant un patient en arrêt cardiaque.

Et on commence le massage cardiaque sain avant, donc, sans perdre du temps pour aller chercher le pouls carotidien ou le pouls fémoral. De toutes les façons, lorsqu'on ne respire plus, donc, les chances, je le mets entre guillemets, qui va se mettre en arrêt cardiaque, ils sont de l'ordre de quelques minutes pratiquement. Donc, lorsqu'on arrête de respirer pendant un certain temps, pendant quelques minutes, le coeur va s'arrêter de battre et pas conséquent.

Donc, on va directement vers un patient qui est en arrêt cardiaque et qu'on masse. Alors, pour synthèse, l'analyse est faite dans ce sens là. Donc, on évalue la conscience.

Si la victime est inconsciente, on part pour libérer le voyant supérieur et évalue la respiration. Si la victime ne respire pas, dans ce cas là, il est considéré, selon la dernière recommandation, comme étant un patient en arrêt cardiaque. Et puis, il faut qu'on commence le massage cardiaque sain.

Une autre remarque sur la problématique de la respiration, soit que la victime ne respire plus, donc, elle est en apnée pratiquement, soit que la victime fait ce qu'on appelle des gaspes. Et les gaspes sont considérés comme étant des arrêts respiratoires et pas conséquent. Ils sont considérés comme étant des patients qui ont un arrêt cardiaque.

Il faut commencer le massage cardiaque sain le plus rapidement possible. Les chances de récupération sur un patient qui a un arrêt cardiaque sont calculées, c'est à dire en minutes. C'est à dire, si on commence le massage cardiaque sain dans la minute où on découvre l'arrêt cardiaque, généralement, les chances de récupérer sont de l'ordre de 90%.

Alors que ces chances là vont se perdre lorsqu'on commence le massage cardiaque sain au delà de 10 minutes d'arrêt cardiaque. Dans ce cas là, les chances de récupérer sont pratiquement nulles. Et lorsqu'on commence par exemple le massage cardiaque sain après 5 minutes, les chances de récupérer sont de l'ordre de 50%.

Alors, il y a une autre question de Mademoiselle Ariane. En cas d'absence d'arrêt cardiaque, le massage cardiaque sain n'est pas mauvais. C'est une question.

S'il n'y a pas d'arrêt cardiaque, le massage cardiaque sain ne doit pas être fait. A conséquent, le massage, c'est une technique de récupérer un coeur qui ne bat pas. S'il n'y a pas d'arrêt cardiaque, il ne faut pas faire le massage cardiaque sain.

Mademoiselle est amie, donc on peut faire la compression abdominale pour le nourrisant en compression thoracique. Pour le nourrisant, c'est une question qui fait rappeler la gestion d'un patient ou d'une victime qui a un corps étranger, notamment une obstruction totale. Chez le

nourrissant, la compression doit être faite au niveau thoracique.

Le même cas pour la femme enceinte. Ces deux victimes, c'est la compression thoracique qu'il faut faire pour essayer de dégager ou de dégager un corps étranger lors d'une obstruction totale des voies aériennes supérieures. On va commencer par les cinq claques au niveau de l'entraînement des deux omoplates.

Puis après, on passera aux compressions thoraciques qui sont l'équivalence d'une compression abdominale chez un adulte. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Heimlich. D'autres questions ? Allez ! Oui ? Lorsqu'on est devant un patient inconscient et qu'on ne respire plus, car il a une obstruction des voies aériennes, on n'arrive pas à enlever ce corps étranger.

Est-ce qu'il est utile de faire le massage cardiaque ? D'accord. Alors là, la situation chez Heimlich, c'est quoi ? Vous avez présenté une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas suite à un corps étranger total. Dans ce cas-là, qui est l'urgence ? On va mettre ce patient sur le crâneau d'une victime inconsciente et qui est en arrêt respiratoire.

Dans ce cas-là, la priorité est au massage cardiaque externe parce que votre patient est en arrêt cardiaque. Dans ce cas-là, il faut commencer le massage cardiaque externe dans cette situation-là. D'ailleurs, la désobstruction, notamment par la manière de Heimlich, chez un patient qui est conscient, l'objectif est d'éviter l'arrêt cardiaque.

Si on se sent devant l'arrêt cardiaque, c'est le massage cardiaque externe qui prime. C'est l'urgence absolue. L'arrêt cardiaque est l'urgence absolue.

D'autres questions ? Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut... D'accord. Une question de qui ? À quoi sert la PLS ? La PLS, la position latérale de sécurité. Est-ce que la PLS doit être à gauche ou à droite ? Monsieur Zied, la PLS peut être faite soit à droite ou à gauche.

Il n'y a pas vraiment de préférence. L'objectif, c'est de protéger le voyant supérieur en mettant le patient en latérale de sécurité et puis en le surveillant durant la procédure avant le dégagement au niveau d'un hôpital. Vous pouvez la faire soit à droite ou à gauche.

Il n'y a pas de souci. C'est kiff-kiff. Alors, Zied Sadeki, on peut faire une manœuvre, ou bien la manœuvre d'Emlich pour une obstruction partielle ? Je pense que la réponse est dans la question.

La manœuvre d'Emlich est destinée pour désobstruire des voyants supérieurs lorsqu'ils sont totaux. C'est une désobstruction totale. Lorsqu'on est devant une obstruction partielle, il faut surtout ne pas faire cette manœuvre d'Emlich parce que vous risquez de transformer une obstruction partielle en obstruction totale.

Lors d'une obstruction partielle, dans ce cas-là, il faut juste rassurer la victime, l'inciter à tousser et qu'il soit assis d'une façon confortable et de la rassurer et d'essayer de lui encourager à

tousser et donner de l'oxygène éventuellement lorsque les secouristes vont intervenir, lorsque vous allez faire l'alerte. Après, la victime qui a une obstruction partielle doit être dégagée vers un hôpital pour essayer de faire le bilan, notamment les radiothorax et, éventuellement, essayer d'enlever le corps étranger par des manœuvres, par des instruments. Ça se fait à l'intérieur de l'hôpital.

Récapitulons. L'obstruction partielle, pas d'Emlich. Rassurer la victime, la mettre en position assise et l'inciter à tousser.

Chaima Lamrouji dit « Est-ce que le bilan de la victime doit être avant l'alerte ? » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question ? Le bilan de la victime, c'est quoi ? C'est de voir quelle est la situation globale. Est-ce que la victime est consciente, inconsciente ? Est-ce qu'elle est inerte, qu'elle ne bouge pas ? C'est ça le bilan global. Il doit être fait avant l'alerte parce que, lorsque vous allez alerter, vous allez, dans votre message, dire aux équipes de secours quelle est la situation.

Est-ce que votre patient est en arrêt ? Est-ce que votre patient est dans un endroit où il y a du feu ? Il n'y a pas conséquent. Le bilan doit être fait avant l'alerte. « Pour les gestes de secourisme d'obstruction partielle, on peut les faire après les claques ou les compressions pour l'obstruction totale ? » Je n'ai pas très bien compris la question.

Je vais la relire. Pour les gestes de secourisme d'obstruction partielle, on peut les faire après les claques ou les compressions pour l'obstruction totale. Lorsque vous avez une obstruction totale, la manœuvre de Himmlisch se passe par deux phases.

La première phase, c'est les claques et après, la compression abdominale. Pour l'obstruction partielle, il ne faut pas nous donner des claques partielles. Il faut juste rassurer la victime, la mettre en position demi-assise et l'inciter à tousser.

Pour l'obstruction partielle, il ne faut pas nous donner des claques. Pour l'obstruction totale, il faut les claques et après la compression abdominale. Ziyad Sadri dit « Pourquoi ne peut-on pas retirer le garrot avant le bloc opératoire ? » Le garrot, lorsque vous avez une hémorragie qui est généralement foudroyante, vous ne pouvez pas l'arrêter avec les autres moyens de compression.

Deuxième indication, lorsque vous êtes devant un nombre important de victimes et que vous n'êtes qu'un seul secouriste, quand on met le garrot, il ne faut pas le retirer avant le bloc opératoire. Pourquoi cette attitude ? Pour une simple raison. Lorsque vous essayez de desserrer le garrot à l'extérieur de l'hôpital, vous risquez d'aggraver l'hémorragie.

Une fois que vous allez défaire le garrot, il faut rapidement faire l'homostasie chirurgicale. Sinon, vous allez faire redémarrer le saignement et aggraver la situation. Donc, il ne faut pas enlever le garrot avant que la victime soit au niveau d'un hôpital mais surtout au niveau du bloc opératoire.

Une autre question. Est-ce qu'on risque de causer des blessures au cours de massacres cardiaques externes ? Et si c'est le cas, est-ce que ça doit être pris en considération ? C'est une question qui a toujours été posée même dans des réunions scientifiques. Il y a quand même des risques sur chaque geste qu'on fait.

Quelles sont les problématiques causées par le massage cardiaque externe ? C'est généralement les fractures, notamment des côtes, parfois des fractures au niveau de l'abdomen ou parfois des fractures au niveau du poumon. Ce sont des problématiques qui peuvent être survenues au cours du massage cardiaque externe. Généralement, lorsque le massage cardiaque externe est fait d'une façon inadaptée.

Je m'explique. Le massage cardiaque externe est fait dans un point bien précis, surtout au niveau du sternum, qui est un os extrêmement dur. Il doit être très adapté si on le fait en latéral.

Il y a certains gens qui font en latéral par problématiques de non-précision de la zone où on met le massage cardiaque externe. On fait en latéral, par exemple, au niveau des côtes. On risque de casser les côtes.

On risque de causer parfois des lésions pulmonaires. Là, il n'y a pas à se soucier de ça parce que l'urgence est de faire le massage cardiaque externe. Mais il faut apprendre à le bien faire pour ne pas causer ces blessures.

Si par malheur, on va causer une fracture, la fracture va se rétablir par la suite. Dans ce cas-là, on va rétablir les priorités. Notre priorité, dans ce cas-là, c'est de sauver la vie.

Après, on verra la fracture. La priorité, c'est de faire le massage cardiaque externe. Il faut apprendre à le faire correctement dans la zone bien précise pour ne pas causer ce type de dégâts.

De là, c'est important de s'entraîner de façon continue au moment de votre cursus, soit au niveau de la fac, soit même au-delà. Vous serez des responsables des docteurs en médecine. Il faut s'entraîner à le faire d'une façon très régulière pour essayer de ne pas causer ce type de dégâts.

Mais quel que soit le cas, l'objectif principal et la priorité est de sauver la vie du patient. Par conséquent, effectuer le massage cardiaque externe, il ne faut pas hésiter à ne pas le faire sous prétexte qu'on peut causer une fracture d'une côte. C'est une deuxième problématique qu'on peut régler secondairement.

Il n'y a aucune contre-indication. Il faut faire le massage cardiaque externe. C'est un patient qui est en arrêt cardiaque le plus rapidement possible pour donner le maximum de chance à la victime pour lui sauver la vie.

Abdelbasset a posé une question. Comment les compressions vont-elles pouvoir éjecter du son

du cœur ? C'est la théorie. Les compressions, c'est une théorie.

Il y a deux théories qui ont géré cette problématique. La théorie thoracique et la théorie cardiaque. Avant, on disait que le fait de masser le cœur permet d'éjecter.

Lorsque vous faites la compression, vous allez écraser le cœur. C'est un concept dynamique très connu. Lorsqu'on fait la compression, on va faire une éjection du sang du cœur vers les organes nobles.

Généralement, c'est le cerveau qui nous intéresse le plus dans ce cas-là. Lorsque vous faites la décompression, c'est le moment où le sang va... Il y a une pression négative qui va se faire au niveau du thorax. Il y aura un appel du sang vers le cœur.

C'est à ce moment-là que le cœur va s'irriguer par les coronaires. On va sauver le muscle cardiaque. Lorsqu'on fait la décompression, il va y avoir un appel d'air vers le poumon.

Ça donnera une sorte d'oxygène qui va être introduit. La compression va pouvoir éjecter du sang du cœur. La décompression va augmenter le retour veineux et, par conséquent, l'irrigation du cœur au moment de la diastole, notamment l'irrigation des coronaires.

On doit laisser les voyants supérieurs libérés au cours de la RCP. Au cours de la RCP, dans l'évaluation initiale, il faut libérer les voyants supérieurs et voir s'ils respirent pour dire qu'il y a un arrêt cardiaque. Lorsqu'on est un seul secouriste, la priorité est au massage arrière-externe.

Lorsqu'on est deux secouristes, un va s'occuper des voyants supérieurs en essayant de les garder libérés et notamment donner de l'oxygène lorsqu'on a un embut d'oxygène. L'autre va faire le massage arrière-externe avec un rythme de 30 compressions pour deux insufflations. Cela va infliger un rythme cardiaque entre 100 et 120 battements par minute.

Lorsqu'on est un seul secouriste, à l'extérieur, la priorité est au massage arrière-externe. Il faut continuer à faire le massage arrière-externe jusqu'à l'arrivée des secouristes. C'est bon, les amis ? Ziyad Sadqi dit « Pourquoi, en cas de danger, il faut écouter la radio sur un appareil à piles à son fermier dans un local ? » C'est intéressant.

Lorsque vous êtes dans un danger, généralement, il ne faut pas utiliser tout ce qui est électrique parce que lors d'un incendie, par exemple, ça risque de créer un suraccident, notamment des étincelles au niveau électricité. Cela risque de créer un autre danger, notamment le danger électrique. Il faut s'enfermer dans un local pour essayer de se protéger le maximum.

Il ne faut surtout pas utiliser, lorsque, par exemple, il y a un tremblement de terre ou un incendie à grande envergure, les téléphones portables parce que vous allez encombrer le réseau téléphonique pour les agents de secourisme. Dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser tout ce qui est électrique ni tout ce qui est téléphonique pour ne pas encombrer le réseau téléphonique qui est généralement destiné pour les secouristes. Amine, est-ce qu'on arrête le massage après que le

patient se met à respirer ? Éventuellement.

Lorsque le patient va reprendre sa respiration, généralement, on va évaluer encore une fois le patient. Dans ce cas-là, c'est la position latérale de sécurité qu'il faut mettre avant d'envoyer la victime au niveau d'un hôpital pour faire ce qu'on appelle le diagnostic étiologique d'un arrêt cardiaque. Zahid, comment on fait un massage externe pour un nouveau-né en arrêt cardiaque ? Ça ne fait pas l'objectif du GSU1, ça fait l'objectif du GSU2, mais quel que soit le cas, je vais vous répondre.

C'est la même méthode pour un nouveau-né qu'on utilise lorsqu'on va faire, par exemple, le Heimlich pour un nouveau-né. Dans ce cas-là, on va faire de la compression avec les deux doigts. Est-ce que vous me voyez là ? Sinon, on prendra, par exemple, le nouveau-né comme ça et on mettra le massage avec le pouce.

Ça fait partie des objectifs du GSU2, donc on va le voir. Vous allez voir aussi ça sur la réanimation d'un nouveau-né dans une salle de travail lourde au cours de gynécologie. Bouh Hassan, si la victime est morte, quand on arrête le massage cardiaque externe ? L'arrêt du massage cardiaque externe et la décision c'est-à-dire la décision d'arrêter le massage cardiaque externe, généralement en fonction de plusieurs situations.

La décision n'est pas facile en fonction d'état, en fonction de pas mal de paramètres. Généralement, la décision d'arrêter la réanimation à dépouillement de base est faite de façon collégiale, ce n'est pas une décision facile à prendre. Monsieur, est-ce qu'il y a une différence entre alerter et faire alerter ? Vous le faites vous-même.

Faire alerter, vous demandez à un témoin de le faire. Alerter, je prends le téléphone et j'alerte. Alerter, c'est demander à une deuxième personne d'aller faire alerter, lorsque vous êtes deux personnes ou deux témoins, donc deux secouristes, à intervenir.

Pourquoi il ne faut pas aller chercher ses enfants à l'école en cas de danger ? C'est la même réflexion par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Lorsqu'il y a un grand danger, des dangers à grande envergure, des grands tremblements, des grands incendies, lorsque vous allez prendre votre voiture et aller chercher les enfants à l'école, il y a un risque de suraccident. Il y a un encombrement du trafic routier qui est généralement destiné dans ces conditions-là aux actions de secourisme et non pas à ces actions-là.

Quel que soit le cas, lorsque vous avez des enfants à l'école lors d'un tremblement, c'est la même règle d'intervention. Ils vont être protégés. Ils vont être mis à l'égard par rapport au fait responsable au niveau de l'école.

Le massage externe reste toujours utile pour les enfants. Lorsque vous avez découvert un arrêt cardiaque au-delà de 30 minutes, c'est ça ou à beau ? D'accord. Théoriquement, au-delà des 10 minutes d'arrêt cardiaque, les chances de récupération sont pratiquement nulles.

Dans ce cas-là, au-delà de ça, Là, pratiquement, les chances de récupération sont inutiles. Mais la question qui se pose, est ce qu'on est sûr que le patient a fait un arrêt cardiaque pendant 20 ou 30 minutes? Donc, c'est ça la question. Donc, quel que soit le cas, lorsqu'on découvre donc un patient en arrêt cardiaque, il faut commencer le massage externe et après ça, vous allez faire l'analyse.

Mais théoriquement, sur la courbe, donc au delà de 10 minutes, faites les chances de récupérer un coeur. Ils sont pratiquement nuls. Est ce qu'on peut confondre une obstruction totale avec une obstruction croisée en certaines situations? Non, la situation, donc, sont généralement les mêmes.

Donc là, l'obstruction totale, c'est un patient qui ne parle pas, qui ne respire pas et qui ne peut pas tousser. C'est la totale. Alors, la parcellaire, c'est un patient qui qui qui tousse quand même, qui respire et qui peut émettre quelques mots.

Donc, c'est ça la différence entre les deux. Et ce qu'on voit, c'est que dans la partielle, donc généralement, l'intervention est faite dans le fait où on veut donc, on veut la transformer en ou essayer de faire d'enlever le corps étranger. Et ça, c'est une contre indication de ce que vous êtes devant une partielle.

Alors, Hamali, vous avez mentionné qu'après 30 compressions thoraciques, qu'on doit réaliser deux insufflations dans un arrêt cardiaque. Mais on sait très bien qu'il y a plusieurs maladies qui se transmettent par voie orale. Alors, sur le sujet là, donc, sur lorsque vous intervenez, c'est à dire à l'extérieur de l'hôpital.

Alors là, effectivement, par ce risque de transmission de maladies, notamment par voie respiratoire, je ne vous conseille pas de faire la bouche à bouche. D'accord. Et dans ce cas là, c'est le massage cardiaque externe.

Alors, si vous avez donc les gens qui vont intervenir, ils ont fait des matériels pour faire passer l'oxygène, notamment les bavoirs. Donc, c'est le fameux Rieima. Là, on peut faire les insufflations avec ce dispositif, mais surtout, il ne faut jamais faire ça.

Je vous déconseille de faire du bouche à bouche comme ça pour les insufflations. Dans ce cas là, il faut insister sur le massage cardiaque externe, le massage cardiaque externe, le massage cardiaque externe. Lors de la mort subite, est ce qu'il y a utile? Est ce qu'il est utile de faire des gestes d'urgence? Alors là, la mort subite, c'est qu'elle est morte.

D'accord. Mais lorsque généralement la mort subite, la mort subite, ça se voit dans deux grandes situations, soit la mort subite du nouveau né. Généralement, c'est des corps étrangers.

La mort subite du sujet jeune. Généralement, c'est des problèmes cardiaques globalement. Lorsque vous découvrez un patient qui est en arrêt cardiaque, soit enfant, soit soit soit soit

adulte.

Faut. Il faut alerter et respecter la chaîne de survie et commencer le massacre à l'extrême. Puis après, vous faites l'analyse.

C'est bon, les amis. Alors, est ce qu'il y a un risque de cause des fractures de côtes lors des compressions? Donc, oui, il y a un risque. D'accord.

Je n'ai, je n'ai, je n'ai. J'ai répondu à cette question là et là, le risque essentiellement lorsque vous faites un massacre à l'extrême façon inadaptée. Généralement, donc, il faut respecter le lieu où on fait le massacre ou il faut respecter la méthode.

Et puis donc, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner durant toute votre vie. Il faut faire des entraînements tout le temps.

Donc, c'est ça pour essayer de faire un geste de massacre à l'extrême vraiment de façon correcte. D'accord. Mais quel qu'il soit le cas, donc, si en cause d'une fracture, il n'y a pas de souci.

Donc, l'objectif, dans ce cas, la priorité, c'est de récupérer la vie. Puis après, donc, on peut traiter une fracture de côte secondairement si la personne est sauvée. Le garrot ne peut pas engendrer une ischémie.

Effectivement, il peut engendrer une ischémie s'il est fait d'une façon inadaptée. Et c'est à cause de ça que lorsqu'on met un garrot, il faut évacuer le plus rapidement possible, le plus rapidement possible le patient vers un bloc opératoire pour essayer de faire l'hémostase chirurgicale et enlever le corps. Les priorités plus urgentes dans ce cas là, il faut sauver la vie.

D'accord. Deuxièmement, il faut sauver la vie du membre et troisièmement, sauver la fonction du membre. Donc, ça se passe comme ça dans l'objectif.

Donc, il faut sauver la vie. C'est le coeur essentiellement. Après, sauver le membre, la vie du membre, puis secondairement, donc sauver la fonctionnalité du membre.

Donc, c'est ça les priorités en matière d'intervention en urgence au niveau de l'hôpital.